

**Турбина Ю.О., Полунина Н.В., Полунин В.С.**

## **СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ**

ФГБОУ ВО «Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения, 117997, г. Москва

♦ **Актуальность исследования.** В структуре общей заболеваемости в РФ за 2018 год осложнения беременности и родов занимают 3-е место и имеют тенденцию к росту.

**Цель** – изучение социально-гигиенической характеристики и репродуктивного поведения женщин фертильного возраста (ЖФВ) и определение их влияние на здоровье женщин.

**Материалы и методы:** данные медицинской документации и анкетирования женщин в 2017 году в г. Москва.

**Результаты.** Представлена социально-гигиеническая характеристика наблюдаемых женщин, средний возраст которых 32 года, две трети – работающие, четверть – домохозяйки, каждая десятая – студентка, 66% – состоят в браке, 82% – регулярно посещают врача, каждая пятая имеет гинекологическое заболевание, 70% – считают контрацепцию необходимой, 62% – относятся к абортам отрицательно.

**Заключение.** Целесообразно формировать высокий уровень медицинской активности у женщин, как у будущих матерей, начиная со школьного возраста, осуществлять половое воспитание с ориентацией на здоровый образ жизни, уделяя внимание отношению к абортam полового партнера и семьи в целом.

**Ключевые слова:** женщины; социально-гигиеническая характеристика, репродуктивный возраст; гинекологическая заболеваемость; абортam.

**Для цитирования:** Турбина Ю.О., Полунина Н.В., Полунин В.С. Социально-гигиеническая характеристика женщин репродуктивного возраста и ее роль в развитии гинекологической патологии. *Российский медицинский журнал*. 2019; 25(2): 89-91. DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-2-89-91>

**Для корреспонденции:** Полунин Валерий Сократович, доктор мед. наук, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения ФГБОУ ВО «Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова», 117997, Москва, E-mail: [lunapol@yandex.ru](mailto:lunapol@yandex.ru)

**Turbina Yu.O., Polunina N.V., Polunin V.S.**

## **SOCIO-HYGIENIC CHARACTERISTICS OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF GYNECOLOGIC PATHOLOGY**

N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Department of public health and public health, health economics, 117997, Moscow, Russian Federation

♦ **In the structure of general morbidity in Russia for 2018 year of complications of pregnancy and childbirth took place and 3 tend to grow.**

**Aim** – study of socio-sanitary characteristics and reproductive behaviour of women of childbearing age (ZhFV) and determining their impact on women's health.

**Materials and methods:** data from medical records and questioning women in 2017 year in Moscow.

**The results.** Provided social and hygienic characteristics of observed women, average age of 32 years, two thirds, a quarter of workers are housewives, every tenth-student, 66% are married, 82% regularly visit a physician, each the fifth has gynecological disease, 70% believe contraception necessary, 62% are related to abortion adversely.

**Conclusion.** It is advisable to generate a high level of medical activity in women, as the future of the mind, from school age, to carry out sex education with a focus on healthy lifestyle, paying attention towards abortion and sexual partner the family as a whole.

**Keywords :** women; socio-sanitary characteristics, reproductive age; gynaecological morbidity; abortion.

For citation: Turbina Yu.O., Polunina N.V., Polunin V.S. Socio-hygienic characteristics of women of reproductive age and its role in the development of gynecologic pathology. *Rossiiskii meditsinskii zhurnal (Medical Journal of the Russian Federation, Russian journal)*. 2019; 25(2): 89-91. (in Russ) DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-2-89-91>

**For correspondence:** Valery S. Polunin, doctor of medical sciences, Professor of public health and health care, health economics "N.I. Pirogov Russian National Research Medical University", 117997, Moscow, Russian Federation, E-mail: [lunapol@yandex.ru](mailto:lunapol@yandex.ru)

**Conflict of interest.** The authors declare no conflict of interest.

**Acknowledgments.** The study had no sponsorship.

Received 22.04.19  
Accepted 29.04.19

### **Актуальность проблемы**

В области охраны здоровья женщин на первый план выступают проблемы бесплодия и планирования семьи, проблема матери и ребенка, обоснование и частота гинекологических заболеваний [1, 2]. Безусловно, аборт как самопроизвольный, так и прерывание беременности по желанию женщины влияет на частоту рождаемости. Тем не менее, аборт продолжает оставаться весьма распространенным средством ограничения рождаемости. Когорту составляют женщины молодого возраста (18-45 лет). Не смотря на то, что число медицинских

абортов по желанию женщины снизилось с 21,3 в 2010 г. по 14,1 в 2018 г. на 1000 женщин фертильного возраста. Средний возраст вступления в брак  $28 \pm 1,2$  лет [3]. За последние 20 лет вырос средний возраст женщин на момент рождения первого ребенка и составил 20-24 лет (с 156,5 на 1000 женщин в 1990 году по 89,9 в 2017 году). Особенно настораживает данный факт в сочетании с тем, что суммарный коэффициент рождаемости равен 1,75 ребенка на 1 женщину. Средний возраст женщины при рождении первого ребенка – 26 лет, 38, % женщин и 36,4% мужчин использовали контрацептивы до рожде-

ния первого ребенка [4]. В настоящее время репродуктивный возраст сместился до 45 лет в связи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Вопрос об абортах – это часть вопроса о репродуктивном здоровье, репродуктивном выборе и репродуктивных правах человека. Согласно мнению многих авторов, здоровье будущего поколения зависит от количества абортов в анамнезе матери. Заболеваемость является одним из наиболее значимых и доступных показателей, косвенно отражающим степень медицинской активности, как одной из характеристик образа жизни [5–10]. Изучение условий жизни, медицинской активности и полового поведения женщин позволит определить пути по снижению количества абортов и гинекологической заболеваемости в целом.

**Цель.** Изучить социально-гигиеническую характеристику и репродуктивное поведение женщин фертильного возраста (ЖФВ) и определить их влияние на здоровье женщин.

### Материал и методы

Изучение наблюдаемых проводилось по данным медицинской документации и анкетировании в 2017 году в г. Москва. Для изучения социально-гигиенической характеристики была составлена анкета, анализ заболеваемости проводился на основании анализа выборочных карт, заполненных из первичной медицинской документации. Было проанализировано 695 анкет.

### Результаты

Возраст обследуемых женщин колебался от 18 до 45 лет, в среднем составил  $32 \pm 0,2$  года. Изучение социально-гигиенической характеристики исследуемой группы свидетельствовало о том, что работающих женщин 65,1%, являются домохозяйками 22,6%, студентками – 11,4%. 83,2% респондентов имеют высшее образование. Важно отметить, что 41% из работающих женщин думают о смене места работы в виду невысокой заработной платы (35,7%), удаленности от места жительства (22,1%), неудобного графика работы (21,1%), семейных обстоятельств (17,1%), занимаемой должности (16,6%).

В официальном браке состоят 66,2%, в гражданском браке – 8,4%, не замужем – 19%, разведены – 5%. Большинство (73,3%) исповедуют христианство. У 70,7% респондентов есть дети, из них 82,3% планировали рождение детей. Удельный вес беременностей от когорты 1-2 ребенка. Важно отметить, что средний возраст рождений приходится на возраст 25-29 лет. В среднем женщины имеют по 1 ребенку на данный период времени, при этом оптимальным числом детей респонденты считают, в среднем, от 2 до 3. Каждая вторая указала на несоответствие желаемого и фактического числа детей в семье, это связано с тем, что они пока еще не осуществили свой карьерный рост. Удовлетворенность материальным положением в среднем оценили на оценку 7 баллов по десятибалльной шкале. Каждая пятая при наличии удовлетворенности жилищными условиями, отмечала напряженную психологическую обстановку в семье, заключающейся в нередко возникающих конфликтных ситуациях.

Анализ свободного времени показал, что половина находили себя в творчестве и спорте. Большинство опрошенных указывали на использование отпуска для совместного отдыха с семьей. Каждая 10 предпочитала одиночный отдых. Опрос, проведенный среди наблюда-

емых женщин, показал, что каждая третья не занимается спортом, каждая третья посещает спортивный салон 1-2 раза в неделю, только каждая пятая регулярно выполняет физические упражнения. Женщины с одинаковой частотой занимаются различными физическими упражнениями. Удельный вес качества питания соответствует 7 баллов по десятибалльной шкале, связывая данную оценку с недостатком времени на готовку и отсутствие мотивации в правильном питании. На отсутствие вредных привычек, таких как курение и алкоголь, указывали 82,4% и 15,2% женщин соответственно. Важно указать, что в этой когорте большинство составляли женщины вне брака и без детей. Каждая вторая из курящих планирует бросить, объясняя свое желание вредом для своего здоровья и планированием беременности. Среди потребляющих алкоголь на регулярное употребление (2 раза в месяц и чаще) приходится 21,3%.

При анализе медицинской активности женщин отмечено, что 82% обследованных регулярно посещают врача акушера-гинеколога. Установлено, что половина наблюдаются в частной клинике, треть в женской консультации (39,8%), остальные – у семейного врача (27,7%). Наибольшее количество обращений приходится на период беременности, у 80,8% женщин проводятся профилактические приемы. Только 60,7% отмечают своевременное обращение к врачу при наличии заболевания. Каждая вторая пациентка обращается по мере необходимости. Половина опрошенных указывали на свою неорганизованность. Каждая пятая наблюдаемая женщина (20,8%) имела гинекологические заболевания, среди которых встречаются приблизительно с одинаковой частотой патологии эндометрия матки и яичников (44% и 27% соответственно). С нерегулярным менструальным циклом обращаются 55,3%. И только 10% женщин обращаются по поводу первичного или вторичного бесплодия. Наиболее распространенными заболеваниями по данным анкетирования являются эндометриоз и хронический двусторонний сальпингофорит.

Начало половой жизни у наблюдаемых женщин приходится на возраст 14-15 лет, в связи с чем имеется большое количество абортов в анамнезе. Основными рекомендациями при осмотре, которые отмечали женщины, были рекомендации по лечению заболевания (43,3%), по дополнительному обследованию (36,8%), по гигиене полового поведения (34,3%). Среди опрошенных подобные рекомендации выполняли 55,3%. Основной причиной невыполнения, со слов опрошенных, являлась собственная неорганизованность. При изучении удовлетворенности женщин качеством медицинской помощи было установлено, что только 40% удовлетворены своим врачом-гинекологом. Согласно проведенному анализу полового поведения установлено, что 70,5% считают контрацепцию необходимой, и только 11,3% не видят необходимости в ней. Наиболее часто используемыми методами являются: механический (51,3%), прерванный половой акт (43,7%), комбинированные оральные контрацептивы (22,6%). Нередко (56,4%) наблюдаемые принимают решение о контрацепции самостоятельно, 18,4% – советовались об этом со своим половым партнером.

Большинство (62,1%) относятся к абортам негативно. Только 4% женщин считают аборт положительным явлением. Преобладающее количество женщин считали, что прерывание беременности выполнялось из-за больших финансовых трудностей (61,2%). В 65,6% случаях

женщины считают, что принимать решение о прерывании беременности должны оба партнера, в то время как 31,9% указывают, что это право остается только за женщиной. Большинство (84,5%) опрошенных женщин выступают против запрета аборт по желанию женщины. Принимали экстренные контрацептивы для предотвращения наступления беременности (постинор, эскален) 33%. Самопроизвольный выкидыш на ранних сроках у 6,7%, неразвивающаяся беременность отмечена у 11%, внематочной беременности отмечена у 2,3 % из 417 женщин, у которых наступила беременность. Аборты были проведены у 99 женщин, в том числе по медицинским показаниям у 25,5%, по желанию женщины у 69,8%, по желанию полового партнера у 17,9%, по желанию родителей у 5,7%. В отношении выбора медицинского учреждения для проведения аборта респонденты разделились.

### Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о наличии высокого уровня гинекологической заболеваемости женщин молодого репродуктивного возраста. В то же время имеет место недостаточно высокий уровень медицинской активности. С целью снижения гинекологической заболеваемости следует формировать высокий уровень медицинской активности у женщин (будущих матерей), начиная со школьного возраста. Считаем целесообразным проводить лекции по гигиеническому и половому воспитанию, как для девочек, так и для мальчиков, формировать понятия здорового образа жизни, при этом уделяя внимание отношению к абортам полового партнера и семьи в целом. Тем не менее, учитывая, что не только аборты, но и современные средства контрацепции не безразличны для здоровья женщины и ее будущих детей, следует вести активную пропаганду рационального демографического поведения населения с ориентацией на деторождение в оптимальном возрастном периоде (20-25 лет) и применение рациональных средств планирования числа детей в семье по рекомендации врача.

**Финансирование.** Исследование не имело спонсорской поддержки.

**Конфликт интересов.** Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Петров Ю.А., Байкулова Т.Ю. Современные представления о проблеме искусственного прерывания беременности (обзор литературы). *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2016; 8: 727-31.
2. Сосновская Т.С. Бесплодие как социально-демографическая проблема России. Научное сообщество студентов: междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXXII Междунар. студ.

- науч.-практ. конф. 2017; 21(32). URL: <https://sibac.info/archive/meghdis/21%2832%29.pdf>.
3. Российский статистический ежегодник. 2018. *Статистический сборник*. М.: Росстат, 2018.
4. Калачикова О.Н., Груздева М.А. Изменения репродуктивного и брачного поведения населения России (на основе анализа выборочных исследований Росстата). *Социальное пространство*. 2018; 2(14). DOI: 10.15838/sa.2018.2.14.1
5. Радзинский В.Е. Аборты в России. *Status praesens*. 2011; 1: 3-5.
6. Костин И.Н. Резервы снижения репродуктивных потерь в Российской Федерации: Автореф. дис... д-ра мед. наук. М.: 2012.
7. Дикке Г.Б., Яроцкая Е.Л., Ерофеева Л.В. Стратегическая оценка политики, программ и услуг в сфере непланируемой беременности, абортов и контрацепции в Российской Федерации. *Проблемы репродукции*. 2010; 3: 92-107.
8. Ахтямова С.Х., Козеева А.Д., Назмиева Л.Р. Распространенность искусственного прерывания беременности в г. Уфа. *Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья*. М.; 2012; 4: 17-9.
9. Трубин В. Б. Влияние медицинского аборта в подростковом возрасте в 1 и 2 триместрах, на течение последующей беременности и родов. *Российский вестник акушера-гинеколога*. 2012; 3: 39-41.
10. Погорелова А. Б. Аборт и его медико-социальная значимость. М.: *Мать и дитя*. 2015.

### REFERENCES

1. Petrov Y.A., Bajkulova T.Yu. Modern views on the issue of abortion (review of literature). *International Journal of applied and fundamental research*. 2016; 8: 727-31. (in Russian)
2. Sosnovskaya T.S. Infertility as socio-demographic problem Russia. The scientific community students: interdisciplinary studies: sat calendar on the mat. XXXII International. Stud. researcher-Scient. CONF. 2017; 21(32). URL: <https://sibac.info/archive/meghdis/21%2832%29.pdf>. (in Russian)
3. The Russian statistical year-book. 2018. *Statistical compilation*. M.: Rosstat, 2018. (in Russian)
4. Kalachikova O.N., Gryzdeva M.A. Changes in reproductive and mating behavior of the Russian population (on the basis of the analysis of sampling Rosstat). *Social space*. 2018; 2(14). DOI: 10.15838/sa.2018.2.14.1 (in Russian)
5. Radzinskiy V.E. Abortion was illegal in Russia. *Status praesens*. 2011; 1: 3-5. (in Russian)
6. Kostin I.N. Reserves reduce reproductive losses in the Russian Federation: Katege. Dis. Dr. med. m., 2012; 29. (in Russian)
7. Dicke G.B., Yarotskaya L.V., Erofeev E.I. Strategic assessment of policies, programs and services in the sphere of unplanned pregnancy, abortion and contraception in the Russian Federation. *Problemy reproduksii*. 2010; 3:92-107. (in Russian)
8. Ahtjamova S.H., Kozeeva A.D., Nazmиеva L.R. Abortion Incidence in the UFA. *Bulleten' natsional'nogo nauchno-issledovatel'skogo instituta obschestvennogo zdorov'ya*. M.: 2012; Iss. 4: 17-9. (in Russian)
9. Trubin B. B. Effect of medical abortion in adolescence in 1 and 2 trimesters, pregnancy and childbirth during the subsequent. *Rossiyskiy vestnik akushera-gynecologa*. 2012; 3: 39-41. (in Russian)
10. Pogorelova A.B. Abortion and its medical and social significance. *Mat' i ditya*. 2015. (in Russian)